Клинические рекомендации

Травма уха

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.4** — Поверхностная травма уха **S01.3** — Открытая рана уха **S09.2** — Травматический разрыв барабанной перепонки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/812_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Этиология 3

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 3

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр и отоскопия 5

3.2 Общий и биохимический анализ крови 5

3.3 Микробиологическое исследование отделяемого 5

3.4 Камертональные пробы и тональная аудиометрия 5

3.5 КТ височной кости 5

4. Лечение 6

4.1 Обезболивание 6

4.2 Лечение ран 6

4.3 Разрыв барабанной перепонки 7

4.4 Отогематома, перихондрит, раны 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 8

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Рекомендация охватывает поверхностную травму уха (ПТУ: ушиб, отогематома, раны, дефекты раковины) и травматический разрыв барабанной перепонки (ТРБП).
- Отогематому устраняют всегда: **до 48 часов** и **менее 2 см** — аспирация иглой 18G, больше или позже — разрез и дренирование; затем давящая повязка.
- Разрыв барабанной перепонки (попадание воды в ухо недопустимо):
  1. свежая перфорация **менее 25%** площади без выделений из уха, кроме взрывной травмы: наблюдение **1–3 месяца**;
  2. разрыв **менее 50%** площади, кроме взрывной травмы: консервативная миринготластика;
  3. стойкая перфорация (сохраняется **более 3 месяцев**): тимпанопластика у всех пациентов, в том числе после взрывной травмы.
- Инфицированная рана и перихондрит: ранние системные антибиотики **7–10 дней**, фторхинолоны — только взрослым; при инфицированных ранах — столбнячный анатоксин.
- Экстренная госпитализация: осложнения (перихондрит, мастоидит) и необходимость операции.

2. Клиническая картина и классификация

Определения

Термин	Определение
Поверхностная зона уха (ПЗУ)	ушная раковина, перепончато-хрящевая часть слухового прохода, мягкие ткани сосцевидной области
Поверхностная травма уха (ПТУ)	механическое воздействие (удар, ушиб, укус, ранение) в поверхностной зоне уха
Ушиб уха	повреждение мягких тканей без видимого нарушения их целостности
Отогематома	скопление крови между хрящом и надхрящницей ушной раковины после механического воздействия
Посттравматический дефект ушной раковины	частичное нарушение целостности мягких тканей или полное отсутствие раковины (ампутация)
Перихондрит ушной раковины	острое воспаление надхрящницы с переходом на кожу раковины и перепончато-хрящевую часть прохода, без мочки
Посттравматический стеноз слухового прохода	сужение наружного слухового прохода после травмы
Акубаротравма	повреждение среднего и внутреннего уха от одновременного резкого перепада давления и звука высокой интенсивности
Баротравма уха	повреждение среднего и внутреннего уха от резкого перепада давления в слуховом проходе или барабанной полости
Травматический разрыв барабанной перепонки (ТРБП)	нарушение целостности барабанной перепонки от внешних причин

2.1 Этиология

Поверхностная травма

1. удар, ушиб, укус, ранение (колотое, резаное, рваное, огнестрельное);
2. ушиб: удар или падение без повреждения хряща и кровоизлияния;
3. отогематома при более сильном воздействии: борцы, боксёры, тяжёлый физический труд, давление жёсткого головного убора или подушки;
4. укусы, порезы, ранения: дефект раковины вплоть до ампутации;
5. инфицирование раны: перихондрит, деформация раковины, рубцовая атрезия слухового прохода.

Разрыв барабанной перепонки

1. механический: острые предметы, самостоятельная чистка уха («Q-tip injury»), ятрогенно при промывании, удалении инородных тел, аспирации;
2. баротравма: авиаперелёт, ныряние, удар ладонью по уху, взрывная волна;
3. перелом височной кости, огнестрельное ранение;
4. термический: окалина при электросварке, удар молнии;
5. химический: агрессивные жидкости.

У детей чаще тупая травма, баротравма, инородное тело; проникающая травма ватной палочкой, спичкой, шпилькой — самим ребёнком, ухаживающими или ятрогенно при удалении инородного тела.

80–97% разрывов заживают сами **за 2–4 недели** независимо от локализации и выделений, влияет лишь размер дефекта. При взрывной травме с большими перфорациями — в 56–82%, **до 3 месяцев**. Если в ухо попадает вода — риск инфицирования; после минно-взрывной травмы возможна интратимпанальная холестеатома уже **через 6 месяцев**.

2.2 Классификация

Поверхностная травма

1. закрытая (ушиб) и ранения;
2. поверхностная (без повреждения височной кости) и глубокая (с повреждением височной кости).

Разрыв барабанной перепонки

1. по времени: свежая перфорация (**менее 3 месяцев**) и стойкая;
2. с гноетечением или сухая;
3. по размеру: малая — **менее 25%** площади (менее 1 квадранта), средняя — 25–50% (1–2 квадранта), большая — более 75% (более 2 квадрантов).

Нарушения слуха, в том числе при акубаротравме, классифицируют по действующей классификации потери слуха.

Дефекты ушной раковины классифицируют по Ю. Н. Ростокину (1975): частичные верхнего, среднего, нижнего отдела, субтотальные, тотальные; и по H. Weerda (1998): центральные, периферические, частичная реконструкция, дефекты мочки, задние, субтотальные, полная потеря раковины, дефекты околоушных мягких тканей, после ожогов.

2.3 Клиническая картина

Отогематома

1. обычно в верхней половине наружной поверхности раковины;
2. флюктуирующая округлая припухлость синеватого или багрового оттенка;
3. мочку не затрагивает;
4. пальпация обычно безболезненна.

Перихондрит: следствие несвоевременного удаления крови из отогематомы.

1. выраженная боль в раковине и слуховом проходе;
2. раковина увеличена, контуры сглажены, мочка не вовлечена;
3. флюктуация при гное между надхрящницей и хрящом;
4. при позднем обращении гнойное расплавление хряща, секвестры, деформация раковины;
5. лихорадка, бессонница из-за пульсирующей боли, иногда озноб;
6. иррадиация боли в височную, затылочную и шейную область.

Ранения: возможен частичный или полный отрыв раковины; кровотечение из ветвей наружной сонной артерии обычно умеренное.

Признаки повреждения глубжележащих структур

1. интенсивное кровотечение: затылочная, височная, задняя ушная артерии — нужна неотложная помощь;
2. ограничение подвижности нижней челюсти — повреждение сустава;
3. слюна из раны — околоушная железа;
4. парез лицевого нерва;
5. при глубокой инфекции — лабиринтит и внутричерепные осложнения.

Объём повреждения раковины зависит от силы и направления воздействия: от ссадин и кровоподтёков до отрыва и размозжения.

Разрыв барабанной перепонки: снижение слуха, заложенность, небольшой шум; сразу после травмы возможна кровь из уха.

1. акубаротравма: снижение слуха вплоть до глухоты, головокружение, нарушение равновесия;
2. при взрывной травме из-за тяжёлого общего состояния у половины пострадавших повреждение слуха не диагностируют или диагностируют поздно;
3. проникающая травма у детей: разрыв цепи косточек, повреждение лицевого нерва и подножной пластинки стремени, перилимфатическая фистула, гемотимпанум; потеря слуха, головокружение, нистагм, атаксия.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, общего осмотра с тщательным осмотром поверхностной зоны уха и барабанной перепонки, отоскопии, заключений других специалистов и лабораторных данных.

Поверхностная травма: жалобы

1. боль, отёк мягких тканей;
2. кровотечение, дефект тканей раковины, ссадины, кровоподтёки;
3. снижение слуха, головокружение;
4. недомогание, слабость, лихорадка, головная боль.

Разрыв барабанной перепонки

1. механизм: перепад давления (удар ладонью, ныряние, взрывная волна), острые предметы или чистка уха, перелом основания черепа при минно-взрывной травме;
2. резкая боль в момент травмы, снижение слуха, шум, головокружение, нарушение равновесия;
3. кровь или ликвор из уха (перелом основания черепа);
4. звук выходящего воздуха при продувании или сморкании;
5. после попадания воды — слизистые или гнойные выделения.

3.1 Осмотр и отоскопия

Показания к осмотру оториноларинголога

1. все пациенты с подозрением на травму уха: первичный осмотр.

Местные признаки поверхностной травмы

1. гиперемия, отёк мягких тканей;
2. флюктуация — кровь или гной между надхрящницей и хрящом;
3. дефекты раковины (частичный или полный отрыв), хрящевой части прохода, околоушной области;
4. кровотечение.

Отоскопия при разрыве барабанной перепонки

1. свежая перфорация: рваные, не омозолелые края, вывернутые кнаружи или в барабанную полость; иногда кровь в проходе;
2. стойкая перфорация: омозолелые края;
3. диагноз акубаротравмы (баротравмы) при соответствующем анамнезе устанавливается только при отоскопически видимом разрыве, без него картина сходна с туботитом.

Дефекты кожи слухового прохода, кровь в нём или подозрение на отоликворею могут указывать на перелом основания черепа. Системные признаки осложнений: лихорадка, интоксикация, выраженная диффузная головная боль.

3.2 Общий и биохимический анализ крови

Показания

1. все пациенты с травмой уха: развёрнутый общий и биохимический анализы крови.

3.3 Микробиологическое исследование отделяемого

Показания

1. все пациенты с травмой уха: посев гнойного отделяемого с определением чувствительности.

При гнойном перихондрите чаще всего синегнойная палочка; также золотистый стафилококк, кишечная палочка, протей.

3.4 Камертональные пробы и тональная аудиометрия

Показания

1. взрослые с травмой уха и снижением слуха: исключить острую сенсоневральную тугоухость.

Аудиометрия показывает кондуктивную тугоухость и её степень; сенсоневральный компонент указывает на повреждение внутреннего уха. У маленьких детей камертональные пробы трудны.

3.5 КТ височной кости

Показания

1. осложнения: перихондрит, абсцесс;
2. подозрение на повреждение височной кости, слуховых косточек, перилимфатическую фистулу.

Перфорация в задне-верхнем квадранте при проникающей травме может указывать на повреждение косточек или внутреннего уха.

Сопутствующие повреждения (перелом челюсти, околоушной железы, лицевого нерва): консультации невролога, челюстно-лицевого хирурга, нейрохирурга.

4. Лечение

Ушибы ушной раковины специального лечения не требуют; ссадины обрабатывают антисептиком, накладывают асептическую повязку или наклейку.

4.1 Обезболивание

Показания

1. поверхностная травма уха: НПВП по выраженности боли.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев — свечи и суспензия, с 6 лет — таблетки, с 12 лет — капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет — гранулы внутрь, с 15 лет — парентерально.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	в КР «6- ч»	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Ибупрофен внутрь	10–12 лет 300 мг; 7–9 лет 200 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР интервалы не сопоставлены с возрастами построчно)	10–12 лет 900 мг; 7–9 лет 600 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	3–5 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 дней
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Кетопрофен внутрь	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут

4.2 Лечение ран

Показания к местному лечению антисептиками и антибактериальными мазями

1. поверхностная травма уха: местно антисептики и антибактериальные мази.

Средства

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, повидон-йод, хлоргексидин;
2. мази у взрослых: хлорамфеникол, неомицин, бацитрацин + неомицин, мупироцин;
3. у детей неомицин, бацитрацин, мупироцин не применяют.

Кратность — по воспалению и экссудату; обрабатывают до разрешения инфекции или начала заживления.

Профилактика столбняка: при инфицированных и контаминированных ранах вводится столбнячный анатоксин.

Показания к системной антибактериальной терапии

1. инфицированная рана;
2. перихондрит ушной раковины.

Препараты

1. цефалоспорины III и IV поколения, фторхинолоны;
2. длительность около **7–10 дней**;
3. фторхинолоны только взрослым; детям — только цефалоспорины IV поколения.

4.3 Разрыв барабанной перепонки

Показания к выжидательной тактике

1. разрыв **менее 25%** площади, кроме взрывной травмы.

При появлении выделений из уха назначаются системные антибиотики.

Наблюдение длится **1–3 месяца** при свежей перфорации (**менее 3 месяцев**), площади **менее 25%** и отсутствии выделений из уха. Если перфорация сохраняется, показана тимпанопластика.

Показания к консервативной миринготомии

1. разрыв **менее 50%** площади, кроме взрывной травмы.

Консервативная миринготомия заключается в тампонаде слухового прохода коллагеновой гемостатической губкой поверх дефекта.

После процедуры

1. не допускать воды в ухо;
2. не вводить препараты в барабанную полость;
3. без самопродувания, чихания, сморкания;
4. осмотр **через 2–4 недели**, раньше — при выделениях или снижении слуха;
5. материал удаляют **не ранее 4 недель**.

Под местной анестезией лидокаином (10% аппликационно или 1% инфильтрационно, кроме детей до 1 года) с оптикой, через ушную воронку; после туалета и при необходимости освежения краёв материал больше перфорации укладывают поверх неё. Детям — под наркозом, используют и папиросную бумагу.

Показания к тимпанопластике

1. стойкая перфорация после травматического разрыва (сохраняется **более 3 месяцев**), у всех пациентов.

Операция показана даже при признаках заживления, если подозревают

1. перелом или смещение слуховых косточек;
2. холестеатому среднего уха;
3. фистулу лабиринтных окон: вестибулярные нарушения **более 2 недель**, костно-воздушный интервал **более 30 дБ**, смешанная тугоухость.

Показания к диагностической тимпанотомии у детей

1. травма уха с вестибулярными симптомами у ребёнка.

Тимпанотомия позволяет выявить и закрыть перилимфатическую фистулу.

Признаки, при которых подозревают перилимфатическую фистулу

1. сенсоневральная тугоухость;
2. нарушение равновесия, головокружение;
3. нистагм в сторону поражения;
4. перфорация в задне-верхнем квадранте.

Под эндотрахеальным наркозом поднимают тимпаномеатальный лоскут, осматривают окна; при явной травме удаляют или репонируют костные фрагменты. Если после аспирации прозрачная жидкость скапливается у окон **не менее 5 минут** наблюдения — фистула; окна закрывают жиром или фасцией, вестибулярные симптомы обычно проходят.

4.4 Отогематома, перихондрит, раны

Показания к устранению отогематомы

1. все пациенты с отогематомой: устранение для профилактики перихондрита.

Тактика

1. **менее 48 часов** после травмы и диаметр **менее 2 см**: аспирация иглой 18G, вкол у основания гематомы;
2. больше **2 см** или позже **48 часов**: разрез и дренирование без косметического ущерба;
3. профилактика рецидива: циркулярная давящая повязка, матрасные швы, фиксация магнитами.

Анестезия

1. 0,5% прокаин: взрослым и детям старше 12 лет;
2. 2% лидокаин: только взрослым.

Гнойный перихондрит: вскрытие и дренирование абсцесса раковины с удалением некротизированных тканей.

Частичный или полный дефект раковины: устранение дефекта. Хирургическая обработка — как можно раньше, с учётом косметики: удаляют только явно нежизнеспособные ткани, первичные швы, при большом натяжении — направляющие.

Ранение перепончато-хрящевой части слухового прохода: стерильные мягкие эластичные трубки в просвет для его восстановления.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. осложнения поверхностной травмы: перихондрит, мастоидит и другие;
2. необходимость операции: устранение дефекта раковины, слухового прохода и другие.

Выписка

1. нормальное общее состояние: нет лихорадки и интоксикации;
2. нормальный общий анализ крови;
3. нормальное заживление ран.

После выписки из стационара пациент находится на диспансерном наблюдении у оториноларинголога.

Профилактика: техника безопасности на производстве и в спорте, средства защиты головы — шлемы, каски.

При адекватном лечении прогноз благоприятный.

Осложнения без лечения или при неадекватном лечении

1. перихондрит;
2. острый гнойный средний отит, мастоидит, лабиринтит;
3. внутричерепные осложнения;
4. флегмона, абсцесс.

При разрыве перепонки прогноз благоприятный; воспаление среднего уха удлиняет течение, но не меняет исход.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма уха»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`812_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица 1 (обезболивание у взрослых): разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг; интервал кеторолака записан неполно («6- ч»). Сверяйте с инструкцией препарата.
- Таблица 2 (обезболивание у детей): для ибупрофена внутрь интервалы приёма не сопоставлены с возрастными группами построчно.